第二十四章 重点人群的全科医疗服务

本章数字资源

学习提要

- 本章节介绍的重点人群主要包括妇女、儿童、老年人。本章通过对妇女、儿童、老年人生理、心理特点及常见健康问题的概述，介绍了如何为这部分重点人群提供更好的全科医疗保健服务，包括各阶段的保健重点及社区保健措施。
- 在日常医疗活动中，社区全科医生应重视对重点人群的保健服务，充分利用社区资源和相关医疗卫生资源，做好这部分人群的保健工作，不断充实、完善现行保健工作的内容，以提高整个社区人群的健康水平，形成社区中人人关心健康、保护健康的氛围。

以社区为范围的全科医疗服务，其对象应为社区中的全部人群。但是为了提高工作效率，在日常医疗活动中，全科医生通常须重点关注社区卫生服务的重点人群和社区人群的主要健康问题，并将其作为社区全科医疗的重点。

社区重点人群是指在社区中具有特殊的生理、心理特点，或处于一定的特殊环境中、容易受各种有害因素的作用、患病率较高的人群，也称特殊人群或脆弱人群。通常情况下，妇女、儿童、老人因具有特殊的生理和心理特点，属于“脆弱人群”，常作为社区卫生服务的重点人群。全科医生做好社区重点人群健康管理服务，有利于提高社区人群的整体健康水平。

第一节 | 概 述

一、社区卫生服务的重点人群

在不同的文献或教科书中，对社区卫生服务重点人群有着不同的界定或定义。若以性别界定，女性因其特殊的生理特点，较男性有更多的健康危险因素，故被列为重点人群；若以年龄界定，儿童与老年人具有更大的生理弱点与危险性，较成年人更容易患病和死亡，所以要将其纳入重点保护对象；若以职业界定，某些特定工种的职工经常处于某种伤害或危险因素威胁之下，如光、电、化学、微波、烟尘等，其生命与健康更容易受到侵害；若以患者群界定，一些主要慢性病患者为终身带病群体，预期可能受到身体多器官损害的影响乃至死亡的威胁，是医护人员长期精心照护的重点；若以心态或社会情境界定，在社会转变时期经历生活巨变、承受多种压力的人群易发生精神障碍，故其为精神心理卫生的重点干预人群。

社区卫生服务是为社区全体民众服务的，其服务人群的主要健康问题（包括危险和压力）就是服务的中心目标。在社区中对社区人群的界定，需要具体问题具体分析。如在生活社区中，居民成分涵盖了各个性别与年龄段，妇女、儿童和老年人往往人数最多，自然就是该社区卫生服务的重点人群；如在功能社区中，根据功能社区中人口的生理、心理、工作环境中的健康危险因素等来确定功能社区中的重点人群。若功能社区为学校，其重点人群可能是师生双方。

二、重点人群全科医疗保健基本原则及策略

在社区卫生服务中，全科医生在做好临床医疗工作的同时，还需要特别重视本社区重点人群的卫

生服务需求，并据此随时调整自己的工作计划。在社区中，妇女、儿童、老年人是人数最多的人群，也是社区保健的重点服务对象，做好这部分人群的保健工作，有利于提高整个社区人群的健康水平。此外，还有其他人群的重点问题也需要去发掘。全科医生可以采取以下策略主动做好重点人群的保健。

（一）注重个体-群体结合

全科医生在日常诊疗过程中，经常可以通过个体患者发现其背后群体的健康问题；且通过个体患者对于社区人群整体情况的了解，能更有效地促进个体患者“知、信、行”的改变。如在诊治高血压患者的过程中，发现部分患者认为无症状则不必测量血压或不需要治疗，究其原因为其缺乏保健知识或存在错误观念。了解这些信息，有助于全科医生为民众提供有针对性的健康教育。全科医生如能在个体患者照顾中保持对群体问题的敏感性，主动发现群体问题，用与此相关的个体案例及时进行人群健康教育，则易于形成社区中人人关心健康、保护健康的氛围，从而提高个体健康照顾的效率和质量。

（二）完善保健工作

政府部门所规定的重点人群保健内容是对人群的健康危险因素和有限的经济投入进行通盘考虑的结果，不一定能够完全满足人们日益增长的卫生保健服务需求。如妇女保健中的围绝经期问题、儿童保健中的心理行为评价与干预问题、青少年的不良行为问题，乃至空巢老年人的孤独与家庭护理等问题。全科医生要善于评价重点人群的各种保健需求，如有可能应组织团队，通过科学评估，制订有针对性的服务计划，以满足这些新出现的服务需求，并在实践中不断完善现行保健工作的内容。

（三）强化社区参与

社区参与是社区卫生服务与全科医疗成功实施的一个不可缺少的重要因素，对于重点人群保健更是如此。实施重点人群保健需要各种社区资源，如医疗保健及其他服务机构，包括社区卫生服务中心（站）、老年病医院、护理院、养老院、临终关怀院、托儿（老）所、助残机构、营养餐厅等；还有其他涉及社区居民生活质量的服务内容，如营养咨询、心理咨询、家庭护理、送餐服务、环境改良服务等。此外，由居民自发的自助与互助式的各种志愿者组织、患者俱乐部等，也是吸引或动员社区积极参与卫生保健活动的重要形式。我国社区卫生服务开展时间不长，目前上述社区资源尚不健全，亟待完善；全科医生应在社区资源建设中发挥积极的引导与支持作用。

（四）建设合作团队

重点人群保健涉及医疗、预防、教育、康复、心理、营养、环境、劳动保护等多方面，仅靠全科医生是不可能实施的。即使是以医疗为主的问题，如慢性病患者的规范化管理，也有许多保健和日常生活管理的知识、技能需要通过生动细致的教育为患者及其家庭提供指导。对于此类问题的判断与处理，护士往往比医生更加娴熟。而其他与人群健康状态评估和健康干预相关的问题，除了需要全科医生、专科医生，也可能需要动员公共卫生人员到现场参与相关活动。同时，社区团队中社会工作者的作用是不能忽视的，他们在社会学和公共关系方面具有专长，对个体患者、家庭乃至社区人群参与健康活动方面，都可能起到非常重要的宣传、发动、协调和促进作用。我国目前在社区第一线工作的主要是临床医生和公卫医生，需要高素质社区护士等其他人员组成团队。因此，如何根据实际需求调整卫生人力，使其真正适合开展和促进社区重点人群保健，是我国社区卫生服务领域值得研究和解决的问题之一。

第二节 | 妇女基层全科医疗服务

妇女是指 14 周岁及以上的女性。妇女保健（women health care）是妇幼卫生工作的重要组成部分，针对女性一生不同时期生殖生理和心理特点，以预防保健为中心，保健和临床相结合，收集影响妇女健康的各种高危因素信息，进行分析、研究，进而采取相应对策，以降低妇女因生育、节育或生殖功能紊乱而引起的发病、伤残和死亡，促进妇女的身心健康。妇女保健主要包括青春期保健、孕产期保健、围绝经期保健，此外还有围婚期保健和生殖调节期保健。

NOTES

一、妇女不同时期生理、心理特点及常见健康问题

1. 青春期　世界卫生组织（WHO）规定，青春期（adolescence）是从 10 岁开始到 19 岁末。女孩的青春期通常比男孩早 1~2 年，一般可分为早、中、晚三期，每期约持续 2~4 年。青春早期是指月经初潮前的生长发育突增阶段，同时性器官和第二性征开始发育。青春中期以第二性征迅速发育为特点，多数女孩出现月经初潮。青春晚期体格发育缓慢，逐渐停止，骨骺倾向完全闭合，性腺发育接近成熟，第二性征发育也近似成人，具有生殖能力，进入成人期。

青春期主要的健康问题包括：由于缺乏经期卫生保健知识，没有良好的卫生习惯，发生月经病，甚至妇科感染性疾病等问题。随着性功能的发育，此期的少女朦胧地产生了性意识，并渴望探究其中的奥秘；若缺乏必要的性知识及道德法治观念，不能控制自己的性冲动，容易发生不正当的性行为，甚至触犯法律导致性犯罪，影响健康及今后的生育功能。青春期心理特点主要是：生理的巨大改变，可能导致恐惧、羞怯、焦虑等，思想情绪也常不稳定，社区、家庭和学校应注意其身心健康。

2. 孕产期　是指从生命的准备阶段即受孕前的准备阶段开始，到新生儿的早期阶段，包括孕前期、妊娠期、分娩期和产褥期。

孕产期是妇女一生中生理和心理变化较大的时期，也是使妇女暴露于与妊娠和分娩有关的各种危险因素和疾病的时期。孕期妇女全身器官负担加重，易发生各种妊娠并发症，孕妇原有的一些疾病常因妊娠而加重。

妊娠期常见的心理问题为焦虑和抑郁状态。由于妊娠期妇女生理变化较大，其心理状态可分为 3 个时期：较难受期、适应期和过度负荷期。妊娠期主要的健康问题包括：由于孕期生理改变可能导致孕妇情绪改变，而孕妇情绪对胎儿发育影响亦较大。如，当孕妇情绪过度紧张时，肾上腺皮质激素分泌过多，可能阻碍胎儿上颌发育形成腭裂；孕妇长期处于忧郁状态，可能导致其血液中营养成分不足，易产下低体重儿和早产儿。妇女严重的生理、心理改变，甚至可能诱发流产、难产、死胎等异常结局。

分娩期常见的心理问题主要包括不适应心理、焦虑紧张心理、恐惧心理和依赖心理。分娩期易发生的健康问题包括难产、产道的撕裂伤、产后大出血、产后感染等。

产褥期，产妇可能因其角色突然转变为母亲，以及照顾和哺养婴儿等情况变化，易出现心理障碍，如产后抑郁症。在澳大利亚，妇女产后抑郁症发病率高达 20% 左右。国内报道的产后抑郁症发病率与国外相似。在产褥期，产妇既要进行自身恢复，又要担负起哺育和照看新生儿的重任，往往出现免疫力下降，容易发生生殖道感染、出血、乳腺炎等疾病。

3. 围绝经期　围绝经期指的是绝经过渡期和绝经后期早期第 1 年，因卵巢功能衰退表现出与绝经有关的内分泌、生物学改变及临床特征。一般可以分为绝经前期、绝经期以及绝经后期。目前，我国学者一般将 40~60 岁定为围绝经期的年龄范围，通常围绝经期的全过程约为 8~12 年。

围绝经期是妇女一生中必然的生理过渡过程，而不是一种性激素紊乱疾病。妇女在生殖生理上的主要特征是性腺功能逐步衰退，主要生理变化是卵巢内卵泡明显减少，导致排卵减少、停止，卵巢合成的性激素减少或停止，引起月经周期紊乱、经量减少，最终进入绝经期。妇女进入围绝经期，多年的心理平衡被打乱，而尚未建立新的心理平衡，势必带来心理上的重大变化，加上体内激素改变，使这一时期的妇女常发生精神状态的改变，如出现悲观、忧郁、烦躁不安、失眠、神经质等绝经综合征。

围绝经期主要的健康问题包括：妇女围绝经期由于激素水平的变化，可能出现自主神经功能紊乱，血管舒缩异常，雌激素的减少可能导致骨质疏松、骨折；心理上的较大变化加上体内激素的改变，使这一时期的妇女心脑血管疾病、恶性肿瘤的发病率都有所增高。

全科医师及其他社区卫生保健人员在提供健康服务时应重视妇女人群的健康，在重视女性青春期、孕产期、围绝经期等主要时期保健服务的同时，还应重视围婚期、生殖调节期等妇女特殊时期保健，并注意各时期之间的衔接。

二、妇女不同时期全科医疗保健重点

1. 青春期保健 女性青春期是由儿童发育到成人的过渡期。这个时期的特点是:①迅速的体格生长与身心发育,但体格与心理的成熟不相一致;②性成熟与开始性活动,可能尝试第 1 次性行为;③常常缺少知识与技能来作出健康的选择,考虑问题侧重于近期和眼前;④此阶段开始的行为可能成为终身的习惯而导致几年后的疾病。营养问题、精神卫生问题、性与生殖健康问题和物质滥用是这个时期少女的常见健康问题。

全科医生应为这些 10~19 岁年龄段的少女提供保密、不加评判、热情关爱的服务。在有条件的社区可开设“亲情服务门诊”,门诊具备单独的房间、特殊的服务时间、适当的私密性、舒适的周围环境和同伴咨询者等条件,由懂得尊重年轻人、保护隐私和值得信任的经培训的专业人员提供服务,保证适当的交流时间。总之要能吸引并留住人,适宜、舒适并能满足需求。

女性青春期保健的内容为培养良好的生活习惯、营养指导及经期卫生指导和性知识教育。青春期保健应重视健康与行为方面的问题,以加强一级预防为重点,主要包括以下内容。

(1) 自我保健:加强健康教育,使青少年了解自己的生理、心理特点,培养良好的个人生活习惯,注意劳逸结合。

(2) 营养指导:注意营养成分的搭配,提供足够的热量,定时定量,三餐有度。

(3) 心理卫生指导:根据青春期少女的生理心理特点,针对具体问题进行积极的教育引导,培养健康的心理、健全的人格和积极乐观的心态,并鼓励其进行适量的体育锻炼。

(4) 卫生指导:正确认识月经期可能出现的小腹胀痛、疲劳嗜睡等生理现象,注意经期卫生,注意经期保暖和营养。

(5) 性教育:应包括性生理教育、性心理教育、性道德教育及性疾病的知识教育。通过性教育使少女了解基本性生理和性心理卫生知识,正确对待和处理性发育过程中的问题,避免不正当性行为;若存在性行为,要做好心理辅导,加强“安全性行为”教育,避免意外妊娠,预防性传播疾病,还要给予家长支持和指导,避免不恰当教育。

2. 孕产期保健 凡确诊为妊娠的孕妇应填写孕产妇系统管理保健手册,定期到所属医院或社区保健机构进行产前检查、保健。产前检查要求至少 7 次,时间分别为妊娠 6~13 周、14~19 周、20~24 周、25~28 周、29~32 周、33~36 周、37~41 周。孕晚期及有高危因素者,酌情增加次数。妊娠到期后持保健手册到医院住院分娩,出院后母婴一同转入社区保健机构进行产后 3、7、14、28、42 天随访检查登记,发现问题及时处理。若发现孕妇有高危因素,按高危妊娠专案管理,应酌情增加产前检查次数。其具体管理工作如下。

(1) 健康教育:采用多种形式开展健康教育工作,普及围产期保健知识,使群众懂得和掌握各期的保健要求,提高孕产妇的自我保健能力,动员社会和家庭关注和支持孕期保健工作。

(2) 早孕保健:做到早发现、早检查、早确诊,如发现高危孕妇应及时转诊和处理,避免病毒感染和接触有害物质,避免乱服药打针,建立孕产妇保健卡或围产期保健卡。

(3) 产前检查:健全产前检查制度,提高孕 12 周前检查 1 次的初检率,直至分娩。提高产前检查的质量,加强对孕妇健康和胎儿生长发育的观察指导,进行必要的实验室检查,防治妊娠期高血压疾病、妊娠期糖尿病、胎位异常等。认真填写有关的登记表、卡。

(4) 高危妊娠筛查、监护和管理:通过产前检查及时筛出高危孕妇,进行专门登记和重点监护,按其危险程度及早转至上级医疗保健单位诊治,并全面衡量其危险程度,选择最有利的分娩方式,有妊娠禁忌证者,应尽早终止妊娠。

(5) 产日保健:严格执行接产操作常规,加强产程观察,预防和正确处理难产,提高接产质量,严格掌握手术指征;进行床旁教育、端正心态,减少不必要的手术产。防治滞产感染、出血、窒息、冻伤,加强高危产妇的分娩监护等。

（6）新生儿保健：掌握新生儿健康状况，对急危重症新生儿进行重点监护、严密观察。正常新生儿要早吸吮、促进母乳喂养。严格落实消毒隔离制度，防止交叉感染。儿科医师应进产房协助抢救新生儿，产前、产后对母亲传授新生儿喂养和护理知识。

（7）产褥期保健：严格执行产褥期护理常规，防止产褥感染。开展产后访视，做到产后和出院后初访，半个月和满月时再各访视一次，产后 42 天全面检查一次。指导产褥期卫生，进行新生儿卡介苗初种。

（8）建立孕产妇死亡及围产儿死亡评审制度：定期对社区内孕产妇死亡、围产儿死亡情况及原因进行调查分析，找出围产保健工作薄弱环节，明确工作努力方向，制订改进措施，促进工作开展。

3. 围绝经期保健

（1）健康教育：全科医生及社区工作团队通过患者教育和群体宣教等方式，使围绝经期妇女了解此时期的卫生保健知识，重视自我保健，消除无谓的恐惧、忧虑，培养开朗乐观性格，使其对生活、工作充满信心；积极参加各项社会工作，增加人际交往；饮食适当，生活规律；坚持锻炼，保持充沛精力等。并通过心理辅导和咨询等，帮助其顺利度过围绝经期。也要向家属和社会宣传、普及围绝经期保健知识，使家庭和社会都能给予围绝经期妇女更多的关心、安慰、理解、支持和鼓励，帮助她们顺利地度过这个阶段。

（2）绝经综合征的医疗照顾：根据症状的类型、程度和机体状态，制订治疗方案。①非激素类药物治疗：对于仅仅出现如心悸、头痛、头晕、乏力、失眠、烦躁等较轻症状的妇女，心理指导的同时可服用谷维素、维生素及地西泮等药物，对多数症状轻微者都是有效的。②激素替代疗法：激素替代疗法仍为治疗围绝经期雌激素水平低下所致症状的最佳方法，其可以帮助妇女顺利度过围绝经期，并可有效地预防老年期的骨质疏松，有利于胆固醇的代谢等。据报道，围绝经期使用激素替代的妇女约占此期妇女的 10%~20%，且大多数以短期用药治疗围绝经期的近期症状为主，一般用药多在 1 年以内。长期应用激素有可能增加乳腺癌和子宫内膜癌等发病风险，可在补充雌激素的同时加用孕激素，对抗雌激素刺激增生的作用，降低癌症风险。对于激素替代疗法国际上尚存在争议，全科医生应发挥个体能动性，利用循证医学手段，实现患者的知情选择。激素替代治疗的禁忌证包括：已知或可疑妊娠、原因不明的阴道流血、已知或可疑患有乳腺癌、已知或可疑患性激素依赖性恶性肿瘤、最近 6 个月内患有活动性静脉或动脉血栓栓塞性疾病、严重肝肾功能不全。

三、妇女的婚前保健与节育期保健

1. 婚前保健　婚前保健服务是对准备结婚的男女双方，在结婚登记前所进行的婚前卫生指导、婚前医学检查和婚前卫生咨询服务，是优生的基础。目的在于保证健康的婚配，保障结婚双方和下一代的健康。婚前保健已列入《中华人民共和国母婴保健法》。

（1）婚前卫生指导：包括性保健指导、生育知识、避孕知识及优生优育指导等。性保健指导内容有性生理、性心理、性卫生和性道德等，如采用正确方法保持外阴清洁，预防感染；建立和谐性生活；严格遵守月经期、妊娠期、产褥期、哺乳期各生理时期的性生活禁忌等。同时，不能忽视性心理调适和性伦理道德教育。

（2）婚前医学检查：是对准备结婚的男女双方可能会影响结婚和生育的疾病进行医学检查。婚前医学检查的主要疾病包括：①严重遗传性疾病，指由于遗传因素先天形成，患者全部或部分丧失自主生活能力，后代再现风险高，医学上认为不适宜生育的遗传性疾病；②指定传染病，是指《中华人民共和国传染病防治法》中规定的艾滋病、淋病、梅毒、麻风病等；③有关精神病，指精神分裂症、躁狂症或抑郁型精神病以及其他重型精神病；④其他与婚育有关的疾病，如重要脏器疾病和生殖系统疾病等。

（3）婚前卫生咨询：对婚前医学检查中出现的异常情况或其他问题进行解答，为服务对象提供科学的信息，对可能产生的后果进行指导，并提出适当建议。“建议不宜结婚”的情况：①双方为直系血

亲、三代以内旁系血亲；②一方或双方患有重度、极重度智力低下，不具有婚姻意识能力；③重型精神病，在病情发作期有攻击危害行为的。“建议暂缓结婚”的情况：①指定传染病在传染期内；②有关精神病在发病期内；③其他医学上认为应暂缓结婚的疾病。“建议不生育”的情况：发现医学上认为不宜生育的严重遗传性疾病或其他重要脏器疾病。“建议采取医学措施，尊重受检者意愿”的情况：婚检发现的可能会终身传染的传染病患者或病原体携带者。

2. 节育期保健 妇女的生育期一般可持续 30 年左右，优生优育是现代社会的趋势，也是我国的基本国策。我国妇女生育期的绝大部分时间处于节育期，此期是妇女一生中工作、生活和性活动最积极、活跃的阶段，对妇女健康意义重大。《中国妇女发展纲要（2021—2030 年）》明确指出：促进健康孕育、减少非意愿妊娠是完善妇女全生命周期健康服务体系的重要目标，而落实基本避孕服务项目、加强产后和流产后避孕节育服务、预防非意愿妊娠是提高妇女生殖健康的重要措施。开展优生优育咨询，普及节育科学知识，以妇女为中心，推广以避孕为主的综合节育措施。人工流产只能作为避孕失败后的最后补救手段，不应作为常规避孕措施。指导育龄夫妇选择安全有效的节育方法，以降低人工流产率，预防性病的传播。

（1）节育期保健内容

1）节育方法的咨询、指导与服务：基层医生应深入社区、家庭提供生育调节方法的主动服务，详细了解服务对象的要求与问题，帮助其对节育方法进行“知情选择”，并指导其正确使用，做好随访与反馈。对在社区群体中推行各种节育方法的可接受性、安全性及副作用进行流行病学调查研究，为保健服务提供理论依据。对高危人群如哺乳期妇女、剖宫产术后、多次人工流产史，有子宫手术史、子宫畸形、严重全身性疾病者等，及时提供重点服务，避免意外妊娠所造成的不良后果。对各种节育方法进行技术服务和技术质量管理。

2）健康教育：传播有关生育调节的科学知识，改变不科学的生育观、不正确的态度和行为，提高自我保健能力，及时评估教育效果。

3）节育期保健系统管理：技术质量与服务质量的管理；节育手术并发症的管理；节育期保健人员的培训与质量管理及效果评估；统计数据的收集、整理、分析、利用和信息交流。应掌握所管辖社区内的育龄妇女人数、年龄结构，节育措施、使用方法及并发症等情况，并应有专项档案记录。

（2）女性常用节育方法的适应证

1）宫内节育器（intrauterine device，IUD）：IUD 主要作用于子宫局部，使子宫内膜产生非细菌性炎症反应，不利于精子生存和受精卵着床。适应证为要求放置宫内节育器避孕而无禁忌证的育龄期妇女。其禁忌证包括：月经过多、过频或不规则阴道出血；生殖道急、慢性炎症；生殖器官肿瘤或畸形；宫颈口过松；重度陈旧性宫颈裂伤及子宫脱垂；贫血及严重全身性疾患等。

2）甾体激素避孕药：主要成分是孕激素或复方雌孕激素，剂型包括口服、外用及注射剂型（即避孕针），分短效、长效和速效三大类。避孕原理为抑制排卵，改变子宫内膜正常生理状况，不利于孕卵着床；改变宫颈黏液性状，不利于精子进入宫腔。适应证为育龄健康妇女。禁忌证：严重心血管疾病，如心脏病、高血压；血液病及血栓性疾病；急、慢性肝炎，肾炎；内分泌疾病如糖尿病或有糖尿病家族史；子宫、乳房肿块或患恶性肿瘤；哺乳期或产后半年以内；月经过稀或年龄 >45 岁；精神病生活不能自理者。同时，年龄大于 35 岁的吸烟妇女不宜长期使用。

3）紧急避孕法：是一种特殊的避孕方法，仅适用于无保护性交后的妇女，当未及时采用任何避孕措施，避孕套滑脱、破裂，或被强迫后可采用此法。如左炔诺孕酮、米非司酮等。此法不宜作为长期的避孕方法。

（3）避孕失败的补救措施

1）人工流产：适用于妊娠 14 周以内者。禁忌证：生殖道炎症；各种疾病急性期；身体状况不良，不能承受手术；体温超过 37.5℃。术后一般应休息 2 周，禁盆浴及性生活 1 个月。人工流产后出现出血过多、下腹痛明显等症状时，应尽快寻求医疗服务，以免发生危险。

2）药物流产：妊娠早期使用药物致胚胎自行排出，达到流产的目的，即为药物流产，可免去手术对子宫的创伤和由此产生的疼痛。目前使用的药物主要为米非司酮及前列腺素。适用于妊娠 7~8 周以内、惧怕手术、多次宫腔手术操作史、手术困难或危险较大者。有青光眼、哮喘、心肌疾病者禁用。缺点是成功率为 90% 左右，不成功者仍须手术流产。此外，药物流产后，可能出血时间较长，增加感染机会，应同时服用抗感染和止血药，无效时应行清宫手术，不可一味保守治疗。应提醒患者：此法务必在专科医生严密监护下使用，以免发生大出血等危险。

3）中期引产：指妊娠 12~27 周，通过各种方法，使胎儿、胎盘自然娩出。禁忌证同人工流产或药物流产。若流产后出血时间长，分泌物有异味，下腹痛或发热，应考虑有宫腔组织残留或感染的可能，应予及时诊治，最好转专科医院。出现闭经可能为内分泌紊乱、无排卵、宫腔粘连或再次妊娠，也应转专科医院治疗。

（4）育龄夫妇不同时期节育方法的选择：在节育期保健服务中，医师应十分注意运用人际交流和咨询技巧，以帮助育龄夫妇做到对节育措施的“知情选择”，即通过宣传教育、培训、咨询、指导等途径，使育龄夫妇了解常用避孕方法的避孕原理、适应证、禁忌证、正确使用方法、常见副作用及其防治方法，在医疗保健人员的帮助下，选择满意的、适合自己的避孕方法。

1）新婚夫妇：其避孕工具可选择短效避孕药；婚后 2~3 个月，可选用外用杀精剂、阴道避孕环、阴道隔膜等。不宜选择 IUD 以及采用长效口服避孕药或长效避孕针。

2）产后、哺乳期：可选择 IUD，可于分娩后立即放置，也可于产后 42 天放置；亦可选择单纯孕激素长效避孕针、皮下埋植剂；哺乳闭经避孕法或自然避孕法；屏障避孕法及某些易溶解的外用杀精剂等。不宜使用复方口服避孕制剂。

3）生育后阶段：可选择 IUD、皮下埋植剂、长效或短效避孕药及各种屏障避孕法和外用杀精剂。

4）围绝经期：原使用 IUD 无副作用者，可继续使用至绝经后 1 年左右取出。此外，还可选择屏障避孕法、阴道避孕环。

5）分居夫妇：可选择探亲避孕药、短效口服避孕药、安全套、杀精剂等。不宜使用自然避孕法。

6）不同健康状况下的人群：①经量过多、周期不规则或痛经者，可选用短效口服避孕药；②子宫肌瘤或乳房肿块的妇女可选用单纯孕激素类避孕方法；③有心、肝、肾等内科疾病患者，宜用屏障避孕法，外用杀精剂、自然避孕法或绝育术、IUD 等；④有生殖道炎症、盆腔感染史者可选用安全套、口服避孕药或皮下埋植剂等。

四、妇女社区保健措施

1. 建立和健全社区妇幼保健网　妇幼保健网是指由妇幼保健专业机构构成的组织系统，是进行社区妇幼保健工作的组织保障，是开展社区妇幼保健工作的组织基础。中国原有的城乡三级卫生保健网可以作为社区妇幼保健的网络，尚不健全的应该逐渐完善。

2. 开展社区调查　通过社区调查，了解所在社区妇女的人口数、年龄构成、健康状况、主要危险因素及卫生保健需求，以便制订社区妇女保健工作计划，有针对性地开展社区妇女保健工作。

3. 提供社区妇女保健服务　根据社区调查的结果，针对社区妇女的健康状况和卫生问题以及卫生保健的需求，提供相应的服务。服务的内容应该包括有关妇女预防保健知识的宣传教育和健康咨询；开展青春期性教育与咨询；婚前检查与咨询；优生优育咨询与技术服务；计划免疫；定期健康检查；妇女疾病的防治等。也包括对妇女开展系统健康管理。

4. 建立非政府支持组织　社区保健强调社区群众的有效参与，可以在社区中成立一些非政府组织，如妇女小组等，以促进社区妇女的有效参与。世界卫生组织指出：没有一个国家提供的政府卫生保健及社会服务足以取代非政府支持系统的作用，即使想做也做不到。妇女小组等非政府组织是社区专业保健机构与社区群众的中介，是社区保健活动中的骨干力量，在传播卫生保健知识、转变人们的行为方面具有重要的作用。

5. 在全科诊疗中注重妇女健康 全科医生应强化妇女保健意识，提高对于妇女不同生理时期常见疾患的诊疗能力；熟悉必要的筛检咨询项目与内容，清楚特定的疾病状况，如高风险性妊娠，包括未成年妊娠、高龄初产妇女等，或孕期贫血、血压高、蛋白尿、体重增长过快、尿糖阳性、羊水早破等问题，一经发现就应及时联系会诊或转诊，以确保孕妇安全与胎儿健康。

第三节 | 儿童基层全科医疗服务

儿童是指0~14岁（或0~12岁）的人群，从胎儿、新生儿、婴儿、幼儿、学龄前儿童发展到学龄儿童，形体上、生理上和心理上不断发生变化，是一生中生长发育最快的阶段，也是奠定身心健康的基础阶段。儿童的免疫功能尚不健全，缺乏独立生活和自我保护的能力。因此，儿童是社区重点人群，全科医生必须为其提供全面系统的保健服务，才能保障他们的身心健康，提高健康水平。

一、儿童不同时期生理、心理和社会特点及其常见健康问题

根据不同年龄段儿童生长发育过程中所表现的不同特点，可将儿童年龄分为胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期和学龄期，各期儿童的身心发育特点及卫生问题有所不同。

1. 胎儿期 从受精卵形成直到胎儿出生统称为胎儿期。胎儿期完全依靠母体生存，以组织与器官的迅速生长和功能渐趋成熟为主要生理特点，尤其妊娠早期是机体各器官形成的关键期，此时如果受各种不利因素的影响，极易影响胎儿的正常分化，从而造成流产或各种畸形。因此孕期保健必须从妊娠早期开始。

2. 新生儿期 自出生后脐带结扎起至生后28天内称为新生儿期。此时期是小儿开始独立生存适应外界环境的阶段。由于生理调节和适应能力不够成熟，受内、外环境的影响较大。因此，此期小儿的发病率、死亡率高，常有产伤、感染、窒息、出血、溶血及先天畸形等疾病发生。

3. 婴儿期 从出生到满1周岁之前为婴儿期。此期是小儿生长发育最迅速的时期，需要摄入非常多的热量和营养素，但由于婴儿大脑皮质功能不成熟，全身各器官系统的功能不完善，对高热、毒素及其他有害因素的抵抗力弱，容易发生抽搐、呕吐、腹泻、呼吸道感染、营养不良等问题。婴儿期是整个儿童期死亡率较高的时期，半岁后因从母体获得的被动免疫逐渐消失，而自身免疫功能尚未成熟，易患感染性疾病。

4. 幼儿期 从满1周岁到满3周岁之前称为幼儿期。此期儿童生长速度稍减慢，但智能发育较前突出，语言、思维和交往能力增强。这一时期由于自身的免疫功能尚不完善，幼儿期的儿童容易发生中耳炎、泌尿生殖系统感染、传染病和寄生虫感染；由于活动范围的加大，而又缺乏自我照顾的能力，因此容易在家庭和社区环境中发生意外事故或伤害；如喂养不当，可能发生营养不良、贫血等健康问题。

5. 学龄前期 3周岁以后到6~7周岁内为学龄前期。此期儿童抵抗力比幼儿期又有所增强，此期生长速度减慢，智能发育更趋完善，但仍然易发生传染性疾病和寄生虫病、意外事故；如果教养不当可能出现行为异常。

6. 学龄期 从6~7岁到12~13岁间为学龄期。此期身体的生长发育稳步增长，除生殖系统外其他器官的发育到本期末已接近成人水平；智能发育也更加成熟，是接受文化科学教育的重要时期。此期发病率较前有所降低，但近视和龋齿发病率较高。

二、儿童期各阶段的保健重点和措施

1. 胎儿期 胎儿期保健以孕母保健为重点。保证营养，合理安排生活、工作；积极预防感染、妊娠期高血压疾病、流产、早产、异常产等情况；妥善处理孕母心、肺、肾等慢性病；慎用药物，以免对胎儿发育产生不良影响。通过遗传咨询、产前诊断、补充叶酸等手段，降低异常产、早产、宫内生长迟滞、新

NOTES

生儿窒息和感染等的发生率。

2. 新生儿期　新生儿期保健特别强调护理，尤其要重视第 1 周内新生儿的护理，护理重点强调合理喂养、保暖及预防感染。如：居室保持空气新鲜；提倡母乳喂养；新生儿的用具每日煮沸消毒；做听力筛查，尽早发现有先天性听力障碍的新生儿等。

（1）开展新生儿访视：新生儿出院后 1 周内，医务人员到新生儿家中访视，同时进行产后访视。了解出生时情况、预防接种情况，在开展新生儿疾病筛查的地区了解新生儿疾病筛查情况等。观察家居环境，重点询问和观察喂养、睡眠、大小便、黄疸、脐部、口腔发育等。为新生儿测量体温，记录出生时体重、身长，进行体格检查，同时建立《0~6 岁儿童保健手册》。根据新生儿的具体情况，有针对性地对家长进行母乳喂养、护理和常见疾病预防指导。如果发现新生儿未接种卡介苗和第 1 剂乙肝疫苗，提醒家长尽快补种。如果发现新生儿未接受新生儿疾病筛查，告知家长到具备筛查条件的医疗保健机构补筛。在新生儿期要求访视 3~4 次，至少应访视 2 次（初访、满月访），对于低出生体重、早产、双/多胎或有出生缺陷的新生儿根据实际情况增加访视次数，并专案管理。

（2）新生儿满月健康管理：新生儿满 28 天后，结合接种乙肝疫苗第 2 剂，在乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行随访。重点询问和观察新生儿的喂养、睡眠、大小便、黄疸等情况，对其进行体格检查和生长发育评估。提供新生儿喂养、护理和疾病防治等健康指导。

3. 婴幼儿健康管理　满月后的随访服务均应在乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行，偏远地区可在村卫生室、社区卫生服务站进行，时间分别在 3、6、8、12、18、24、30、36 月龄，共 8 次。有条件的地区，建议结合儿童预防接种时间增加随访次数。服务内容包括：①询问上次随访到本次随访之间的婴幼儿喂养、患病等情况。②进行体格检查，做生长发育和心理行为发育评估。③进行母乳喂养、辅食添加、心理行为发育、意外伤害预防、口腔保健、中医保健、常见疾病防治等健康指导。④在婴幼儿 6~8、18、30 月龄时分别进行 1 次血常规检测。在 6、12、24、36 月龄时使用听性行为观察法分别进行 1 次听力筛查。⑤在每次进行预防接种前均要检查有无禁忌证，若无，体检结束后接受疫苗接种。

4. 学龄前期儿童健康管理　4~6 岁的学龄前儿童每年可享受一次健康管理服务。散居儿童的健康管理服务应由乡镇卫生院、社区卫生服务中心提供，集体儿童可在托幼机构进行。服务内容包括：①询问上次随访到本次随访之间的膳食、患病等情况。②进行体格检查，做生长发育和心理行为发育评估、血常规检查和视力筛查。③进行合理膳食、心理行为发育（特别要注意健康人格的形成，此期儿童好奇多问，求知欲旺，具有较大的可塑性，因此要注意培养其良好的道德品质、良好生活和学习习惯，为入学做好准备）、意外伤害预防、口腔保健、中医保健、常见疾病防治（学龄前期儿童易患肾炎，风湿热等疾病，应注意防治）等健康指导。④教育幼儿家长注意弱视、斜视的早期症状，弱视的危害极大，如能在 4 周岁以前及时发现，就能达到较为满意的治疗效果。但如果错过了最佳治疗时期（10 岁以前未能治疗），将对孩子今后的视功能造成严重的影响。弱视的儿童其平时表现与一般近视、远视等症状很相似，且幼儿不能用言语表达其视力情况，家长不易发现，主观视力检查困难，应对此期儿童进行视敏度筛检等客观检查，包括弱视和斜视检查。⑤在每次进行预防接种前均要检查有无禁忌证，若无，体检结束后接受疫苗接种。

5. 学龄期儿童健康管理　此期保健应注意保证营养，创造良好的生活、学习环境，养成良好生活、学习习惯和正确的坐、立、行走、阅读姿势，加强体育锻炼，预防肥胖、代谢综合征。加强安全教育，预防意外损伤，注重德、智、体、美、劳全面发展。特别要注意健康人格的形成。

三、儿童保健系统管理

为了更好地保证社区儿童的健康，需要对儿童保健进行主动的系统管理。在国内开展了主要针对 7 岁以内的儿童，重点是新生儿和 3 岁以下婴幼儿的儿童保健系统管理。

儿童保健系统管理的运行程序，在城市是以街道或居委会为单位，由所在辖区的医疗保健机构承担工作，并根据其能力大小实行就近划片包干责任制。在农村依靠三级妇幼保健网络，以乡为单位，

实行分级分工负责制，乡村配合，共同做好儿童保健系统管理工作，疑难病儿转县（市）级以上医疗保健机构处理。儿童保健系统管理措施如下。

1. 在医院儿童保健科建立儿童保健卡（手册） 婴儿出生后即建立系统保健卡（手册），做到一人一卡（手册），并交由承担系统保健的机构管理。

2. 建立儿童保健网络系统 通过社区卫生服务网络能够有效地将社区儿童保健服务内容推广到每个适龄儿童，且不会对每个家庭造成经济和社会负担。建立本地区儿童健康档案数据库，定期收集本地区儿童健康资料，包括各种常见病资料，存档，分析常见疾病发病率、死亡率，发现影响本地区儿童健康的主要因素，协调相关公共卫生和妇幼卫生工作等，为本地区政府制定相关政策提供依据。

3. 对入托前儿童进行管理 建立三表制，开展生长发育监测和筛查工作（包括儿童口腔、眼保健及弱视、斜视和近视的筛查；疑诊儿童及时转诊，并协助随访），疾病的筛查和诊治，营养、喂养指导，儿童心理行为问题处理，智力筛查，开展新生儿访视以及本地区疾病预防等；对托幼园所卫生保健工作进行指导和管理，开展健康教育等。

4. 主动发现个案 全科医生与儿童及其家庭的密切接触，有利于及时发现各种生理、心理、社会方面的异常情况，并及时进行调适。如在诊疗中发现患病儿童家庭中“真正的病因”，或从儿童生理疾患的表象中觉察背后的精神心理社会问题，包括父母失和、虐待儿童、“留守儿童孤独”问题等，并通过与有关部门联系及时解决这些问题，都将对社区儿童健康成长极为有益。

5. 体弱儿的管理 对儿童保健门诊和系统管理中发现和筛选出的体弱儿要进行专案管理。体弱儿是指低体重儿（出生体重小于 2 500g）、早产儿、智力障碍儿童、佝偻病活动期、Ⅱ度以上营养不良、中度以上缺铁性贫血、反复感染，以及患先天性心脏病、先天畸形、遗传代谢病等疾病的儿童。对体弱儿要采取针对性措施，定期访视，指导家长正确护理、喂养，注意保暖，防治感染等。要督促患儿就医，建立专案病历，制订治疗方案，定期复诊治疗。待恢复正常情况和疾病治愈后，转入健康儿童系统管理。

第四节 | 老年基层全科医疗服务

一、老年、老龄化与健康老龄化的概念

（一）老年的界定

关于老年的标准，目前世界上尚未统一。WHO 建议亚太地区和发展中国家用 60 岁作为老年标准。我国人口学上将老年人不同年龄阶段分为：45~59 岁为老年前期（中老年人），60~79 岁为老年期（老年人），80 岁及以上为高龄期（高龄老人），90 岁及以上为长寿期（长寿老人），100 岁及以上为百岁老人。也有专家界定为，69 岁及以下者为低龄老人，70~79 岁者为中龄老人，80 岁以上者为高龄老人。

（二）老龄化的概念

根据联合国划分人口老龄化程度的标准，人口老龄化基本的内涵是：总人口数中 60 岁及以上的人口所占的比例超过 10%，或者 65 岁及以上的人口所占的比例超过 7%，总人口年龄中位数超过 30 岁，0~14 岁的少儿人口占总人口的比例低于 30%，老年人口与少儿人口的比值在 30% 以上。

中国是世界老年人口最多的国家之一，也是世界人口老龄化速度最快的国家之一。我国在 2000 年 60 岁以上人口占总人口的比重达到了 10%，就已经进入老龄化社会。我国人口老龄化与其他国家（特别是经济发达国家）相比具有以下特征。

1. 老年人口规模巨大，老龄化发展迅速。截至 2022 年末，全国 65 周岁及以上老年人口 21 035 万人，占总人口的 15.38%，全国 65 周岁及以上老年人口抚养比由 2013 年的 13.1% 上升到 2022 年的 21.8%。根据国务院发展研究中心课题组预测，到 2035 年和 2050 年，中国 65 岁及以上老年人口规模将分别达到 3.46 亿和 4.49 亿，老龄化率达到 20.5% 和 37.3%（国务院发展研究中心课题组，2022）。

2. 地区发展不平衡，城乡倒置。中国人口老龄化发展具有明显的由东向西的区域梯次特征，东部沿海经济发达地区明显快于西部经济欠发达地区。在最早进入人口老龄化行列的上海（1979 年）和最迟进入人口老龄化行列的宁夏（2012 年）之间，时间跨度长达 33 年。同时，中国的老龄化的状况长时间城乡倒置。从城乡分布看，由于我国城市化的加速，农村青壮年劳动力转移，大量的农村劳动力迁移到城市，农村的人口老龄化程度和速度高于城市，农村面临着老龄化等严重问题。第七次全国人口普查数据显示中国乡村老龄化程度为 23.8%，比城镇高 7.99 个百分点。但与此同时，根据我国人口发展的规律，预计到 2040 年，我国城乡倒置的老龄化人口分布状况将会发生改变，城镇水平将高于农村。

3. 总体上看，中国女性老年人口数量多于男性老年人口，老年人口性别比近 30 年来呈先升后降的变化趋势。从 60 岁及以上老年人口的性别构成看，2020 年我国男性老年人口有 12 738 万，女性老年人口有 13 664 万，女性老年人口数量略多于男性老年人口数量。从性别占比来看，男性老年人口占老年人口的 48.25%，女性老年人口占 51.75%。

4. 人口老龄化速度大于社会经济发展速度。发达国家进入老龄社会时，人均国内生产总值一般都在 5 000 到 1 万美元以上。2022 年，中国人均国内生产总值为 12 242 美元，但地区之间发展不均衡，最大可差距 4.2 倍，应对人口老龄化的经济实力与其他国家相比仍较为薄弱。

5. 老年人群慢性病高发。从健康状况看，目前我国 60% 老年人患各种慢性疾病，失能、半失能人数达 4 000 万，完全失能人数达 1 200 万；2019 年，健康中国行动推进委员会办公室召开发布会公布，截至 2018 年底，中国人均预期寿命是 77 岁，但是健康预期寿命仅为 68.7 岁，也就是说，中国老人大致有 8 年多的时间带病生存。

因此，如何提高老年人的生活质量，如何建立健全各层次老年卫生保健康复体系，如何将我国政府给予老年人的关怀落实到每个老年人身上，是社区全科医生面临的新课题，也是义不容辞的社会责任。

（三）健康老龄化的概念

1987 年 5 月召开的世界卫生大会，最早提出“健康老龄化”（healthy aging）的概念，其强调长寿和健康并重，生存的质和量统一，并将此作为全社会的奋斗目标。健康老龄化的外延包括老年人的个体健康、老年人群体的整体健康和老龄化社会人文环境的健康等内容。

二、老年人生理和心理特征及主要健康问题

老年人健康是一个相对概念，其衰老、疾病和健康并无明显界限。老年人健康问题往往是长期的、复杂的，但其中又有很多规律和特征，全科医生只有对老年人的生理、心理特点有充分的了解，才能为这一重点人群提供更好的医疗保健服务。

（一）老年人生理特征

老年人生理变化主要有：毛发变白、脱发，皮肤皱纹增多、弹性减弱等体表外形改变；体内主要器官实质细胞数目减少，引起器官萎缩、功能下降；机体调节控制作用下降。全身各系统如皮肤感官、呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿系统、内分泌系统、生殖系统、免疫系统、肌肉骨骼系统、神经系统等的系统功能出现不可逆转的退行性改变，人体免疫功能明显下降，罹患各类感染性疾病的概率大大增加。

（二）老年人心理特征

老年人心理健康状况随生理功能的衰弱、生活环境和社会角色的变化而变化，由于个体的家庭环境、教育背景、经济状况和健康状况等的差异，表现出比生理健康更为复杂多样的变化。一般表现为感知觉下降、智力衰退、记忆思维能力下降、人格特征和情感改变等。丰富的生活经历使他们在漫长的生活中形成了一些对事物的固定看法，晚年可能由于家庭及社会环境的变迁等因素影响，会表现出一些不同性质的精神行为障碍，如孤独、多疑、自卑、抑郁以及情绪不稳、脾气暴躁等。逐渐步入高龄

后，表现出记忆力减退，注意力、判断力、计算力等都有所下降，发生定向障碍。同时，有些老人还伴有人格丧失和异常行为等，构成老年人的社会和家庭问题。

（三）老年人主要健康问题

调查显示，约 70% 的老年人同时患有 2 种或 2 种以上疾病。尽管老年人存在着个体差异，但其健康问题主要集中在常见慢性病及其急性合并症，所患疾病涉及全身各个系统。

老年人易患的慢性疾病或健康问题，多见于：骨关节病变、高血压、心脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病、伤害与意外事故的不良影响、慢性肝病与肝硬化、眩晕、听力障碍、视力障碍、白内障、尿失禁、静脉曲张、动脉硬化、慢性肺部疾病、痔、便秘、慢性肾病、甲状腺功能减退症、帕金森综合征、精神疾病（如抑郁症与痴呆）、皮肤炎症，以及各种功能障碍。老年人常患的急性问题，多见于：脑卒中、急性心肌梗死、急腹症、流行性感冒、肺炎、伤害与意外事故、骨折、腹泻等。此外，跌倒、药物不良反应、功能老化、高龄等情况，均可导致老年人急、慢性病的发生，故也应将其列为健康问题。全科医生应做好老年人健康和疾病的评估、治疗、适时转诊、随访等工作，并掌握老年期患病的特点。

（四）老年期患病特点

老年期个体差异很大，适应性、代偿能力、反应性等各不相同，临床表现有其个体特殊性。但是从老年人整体临床特点上来看，具有以下特征：①临床症状不典型：很多老年人没有疾病典型的临床症状，常表现为全身不适、乏力、表情淡漠、意识障碍，甚至昏迷等，容易造成漏诊。老年人整体反应性低下，在很多疾病的发生发展过程中，疾病的临床体征不典型，主观感觉与客观体征不一致，易发生误诊。②老年人虽发病隐匿，病情却发展迅速。③易出现多脏器衰竭：老年人尤其是高龄老人很多脏器功能都处于边缘状态，稍有应激就会出现脏器功能失代偿，进而出现多脏器功能衰竭，诱发危象。④治愈率低：老年人各脏器功能衰退，神经内分泌调节机制减弱，应激能力下降，疾病的治愈率明显降低，且不易恢复。⑤多种疾病共存：衰老和疾病造成了老年人病情复杂，涉及多系统。多种疾病共存是老年患者的重要特点之一，给疾病的诊断、治疗都带来困难；老年人脏器功能老化，代偿储备不足，使他们在治疗过程中容易出现各种并发症。⑥治疗和预后特点：老年人患病后具有治疗矛盾多、个体差异大、依从性差、药物不良反应多等特点，患病后并发症多、失能率高、病死率高为老年期疾病预后特点。

三、全科医疗中的老年保健

老年期的生理、心理和社会特点，决定了老年人群复杂多样的医疗保健需求，既包括预防保健、医疗、护理和康复需求，也包含了心理服务需求，给社区老年卫生保健工作提出了挑战。社区全科医生应该在对社区老年人群科学评估的基础上，充分利用社区资源和相关医疗卫生资源，做好老年保健工作。

（一）社区老年健康管理重点人群

社区老年人口庞大，健康及疾病程度不同。全科医生的老年健康管理应着重针对以下人群。

1. 高龄老人 高龄老人是指 80 岁以上的老人。高龄老人对医疗保健的需求大，又多同时患有多种疾病，易出现系统功能衰竭，其健康维护、疾病治疗康复均是老年健康保健管理的重要内容。

2. 独居老人 伴随社会发展，家庭趋于小型化，空巢老人、由老年人自己组成的家庭将越来越多。独居老人增多使基层老年服务增多。

3. 丧偶老人 丧偶老人的孤独感和心理问题发生率更高，对老年人的健康不利，会导致原有疾病的复发。

4. 新近出院的老人 新近出院的老人因疾病未完全恢复，身体状况差，常需要继续治疗和及时调整治疗方案。

5. 老年精神障碍者 老年人中的精神障碍者包括痴呆患者。重度痴呆的老年人生活失去规律，常伴有营养障碍，加重原有的躯体疾病，使平均寿命缩短。

（二）老年健康管理主要内容

老年健康管理服务主要包括：疾病预防、自我保健、健康教育、周期性健康检查、营养与膳食指导等。具体技术包括老年综合评估、健康教育、健康检查、日常生活管理、医疗服务、护理与康复服务、心理健康服务、临终关怀服务。

1. 老年综合评估　老年综合评估（comprehensive geriatric assessment，CGA）又称“老年健康综合评估”，是采用多学科方法评估老年人的身体健康、功能状态、心理健康和社会环境状况等，并据此制订和启动以保护老年人健康和功能状态为目的的治疗计划。其能鉴定出老年人医疗、社会、心理等多方面的问题，反映出老年人的保健需求，最大限度地提高老年人的生活质量。通过评估使全科医生的工作更全面、科学、有针对性。

（1）老年综合评估适用人群：根据 2017 年《老年综合评估技术应用中国专家共识》，老年综合评估适用于 60 岁以上，已出现生活或活动功能不全（尤其是最近恶化者），已伴有老年综合征、老年共病、多重用药，合并有精神方面问题，合并有社会支持问题（独居、缺乏社会支持、疏于照顾）以及多次住院者。对于合并有严重疾病（如疾病终末期、重症等）、严重痴呆、完全失能的老年人以及健康老年人可酌情开展部分评估工作。

（2）老年综合评估的主要内容：CGA 的评估内容比较广泛，主要包括躯体功能状态、机体功能、精神心理状态、社会支持、生活环境 5 个维度的评估，有以下项目（表 24-1）。

表 24-1　老年综合评估主要评估维度及工具

评估维度	评估项目及工具
躯体功能评估	日常生活活动能力评估、平衡和步态评估、Morse 跌倒评估量表等
机体功能评估	营养评估、衰弱评估、肌少症评估、疼痛评估、共病评估、多重耐药评估、睡眠障碍评估、视力障碍评估、听力障碍评估、尿失禁评估、口腔问题评估、压疮评估
精神心理状态评估	认知功能评估、谵妄评估、焦虑评估、抑郁评估
社会支持评估	客观支持评估、主观支持评估、对支持的利用度评估
生活环境评估	居家环境评估

2. 健康教育　老年人的适应能力、抗病能力和代谢能力都有明显的降低，有必要接受有关专业人员的指导。通过接受健康教育，老年人自己能制订合理的生活方式，如保持适量的活动。生活要有规律；保持充分的睡眠；平衡膳食，注意营养素的搭配；适量饮茶；保持心情舒畅平静，不宜过于激动等。

3. 健康检查　老年人要定期体检，每年至少一次。全科医生应根据周期性健康检查的要求，对老年人开展体检。发现问题并及时采取保健措施，必要时向上级医院转诊。

4. 日常活动管理　全科医生应对老年人的日常生活给予必要的指导。

（1）饮食：由于老年人胃肠功能减退以及营养不良、偏食等，进食量逐渐减少，同时代谢量及运动量也逐渐减少，所以老年人饮食宜清淡，应减少盐的摄入量，每天不超 5g。此外，还应多吃蔬菜、水果，增加钙的摄入，宜多吃一些海藻、小虾、牛奶等含钙量丰富的食物。

（2）排便：老年人常因食量减少，纤维素摄入不足，胃肠功能低下以及腹肌收缩力降低等原因而便秘。为防止便秘，可适当多吃一些富含纤维素的食物，也可以采用清晨饮一杯水、果汁或蜂蜜水等通便措施。多鼓励老人在有便意时排便，必要时可采取栓剂或灌肠。

（3）排尿：部分老年人肾功能减退，膀胱颈部硬化或患有神经性膀胱炎、前列腺增生而易引起排尿障碍，常出现尿少、尿频、夜间尿频、尿失禁、尿线变细等症状，应采取措施加强指导，如控制晚餐后水分摄入，注意保暖，床边备有夜间使用的便壶等。

（4）控制体重：肥胖是影响健康和长寿的重要因素之一，还会给支持体重的关节增加负担。减轻

体重的原则有两条：一是减少热量的摄入，控制碳水化合物以及脂肪的摄入量，但不应减少蛋白质的摄入；二是增大运动量，但注意运动要适当，应根据老年人特点和每个人的具体情况制订个体化运动处方，并注意运动过程中的安全。

5. 医疗服务 老年期患病有其特殊性，全科医生应熟悉老年患者的特点，正确判别疾病及其严重程度，根据病情提供适当的诊疗服务。尤其要根据患者情况组织以病人为中心的医疗照顾团队，为患者提供针对性的医疗服务。

6. 护理与康复服务 在疾病或失能的情况下，老年人需要得到清洁卫生、饮食、起居、药物等护理服务，促进疾病的早期康复；对疾病等引起的机体病残与失能，需要有效的康复服务和指导。

7. 心理健康服务 在老年期，老人的社会地位、人际关系、经济状况、健康状况会发生不同程度的变化，除了满足其对疾病诊疗的医疗服务需求，还需要使其保持健康状态的心理健康咨询并学会自我调节。在人际关系和人际交往、社会适应方面也需要给予心理辅导，在疾病状态下需要提供心理护理等。

8. 临终关怀服务 临终关怀服务不仅强调支持性和缓解性的治疗和照护，还包括心理咨询、死亡教育、社会支援和居丧照顾等多层面的综合性服务；另外对临终患者的家属进行的心理咨询和安慰也是临终关怀服务的重要内容。帮助临终患者的家属最有效的办法是和他们保持真诚的关系，倾听他们的诉说、由衷地宽慰，帮助他们走过悲伤的日子，克服消极的情绪，开始新的生活。

四、老年人社区保健主要措施

我国正面临着人口老龄化给卫生保健带来的挑战，面对日益扩大的老年人群，要在社区范围内做好老年保健工作，满足其卫生保健服务的基本需要与需求，就必须建立一个较为完善的老年保健体系，制订可以实施的老年保健计划。目前，我国老年保健体系尚未健全，而社区卫生服务机构在老年保健中担当着重要角色。全科医生如何能够在现有经济、保健体系条件下做好对老年人的长期照顾工作、满足老年人卫生保健需求，让老年人的健康有最大的保障，是非常值得研究的问题。

1. 建立和健全老年社区保健网 社区开展老年保健系统管理工作需要社会、社区各部门的支持和配合。因此，全科医生作为开展社区老年保健系统管理工作的主角，需要与社区内卫生及非卫生部门通力协作，建立和健全老年社区保健网，开展老年人内在能力、衰弱、失能等综合评估，精准管理，利用互联网和信息化技术整合防治体系，形成社区与医院的健康医疗管理闭环。对于出现内在能力下降的老年人，要提供个体化、规范化的综合诊疗和干预服务，实现以人为中心的老年人全方位、全周期健康管理，共同做好社区老年人的医疗保健工作。除卫生部门，中国的老年保健组织、行政机构还有老龄委员会，从中央到省、市、县、乡各级都建立了老龄工作办事机构；民政部门，从国家民政部到省市级民政厅局、县级民政局、乡镇民政干事，组成了负责管理老年人福利事业的机构。

2. 建立健全老年人健康档案 社区老年人保健的服务对象是社区内所有老年人，每个老年人因健康状况和生存质量的差异，所需的服务项目和内容是不同的。因此，必须对老年人的健康状况、生存质量以及潜在的卫生服务需求进行调查，并对调查获得的资料进行科学分析和评价，在此基础上建立老年人健康档案，为开展社区老年人的分级管理及制订社区医疗保健计划提供依据。

3. 开展社区老年人的系统管理工作 不同年龄的老人生理功能的衰退程度不同，不同老年人在生命活力、患病情况、生活自理能力上各有差异。有必要将社区内的老年人，根据其生活自理能力、年龄、患病情况等方面的差异，逐个进行分析，分为不同的类型，分别给予不同的医疗保健监护，实行分级的系统管理；并提供从健康教育、心理咨询到住院、门诊治疗、日常生活护理等一系列系统的、连续性的卫生保健服务，真正达到主动服务、预防为主、适宜服务、避免浪费、提高效率的社区保健宗旨。

4. 建立社区非政府支持组织 社区非政府支持组织是指社区内的一些对老年人具有帮助和支持作用的群众组织。因为，对老年人的照料不能仅限于疾病，还应包括整个老年幸福生活。要考虑物质、精神、社会、自然环境等因素相互依存的关系。老年社区保健也不应仅限于提供医疗卫生服务，还

应包括其他社会服务。社区非政府支持组织通过组织老年人开展各种有益于身心健康的文体活动、互助互济活动等，在老年人社区保健工作中发挥巨大的作用。

（葛　伟）

思考题

1. 社区全科医疗服务重点人群的概念是什么？社区全科医疗保健基本策略及原则是什么？

2. 阐述社区老年健康管理主要内容。

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图